

25 - MORT FŒTALE IN UTERO (MFIU) - Pr. ABOULFALAH

Bonjour, je suis le professeur Apoel Falah, service de gynécologie occitrique du CIHU de Marrakech. Le cours d'aujourd'hui concerne les morts fœtales in utero. La mort fœtale in utero est définie par le décès du fœtus qui survient entre 22 semaines d'aménorrhée et le début du travail.

Donc elle fait partie de la mortalité périnatale. Il s'agit d'un indicateur d'évaluation des systèmes de soins et demeure un problème de santé publique au Maroc. Le diagnostic positif est facile, il se fait par l'échographie.

Mais le bilan étiologique afin de prévenir les grossesses ultérieures et les morts fœtales in utero doit être exhaustif. Les morts fœtales in utero exposent un risque de complication parfois très grave chez la maman. C'est pourquoi une fois le diagnostic fait, il faut assurer une évacuation utérine.

Bien évidemment, l'intérêt du bilan étiologique doit déboucher dans les grossesses ultérieures sur une prévention. Au plan épidémiologique, la fréquence des morts fœtales in utero est très variable en fonction des pays et des régions, en fonction du niveau socio-économique. Elle varie de 1 à 10% en fonction du contexte.

L'étiologie, on retrouve trois ordres de causes. Tout d'abord les causes maternelles, les causes annexielles et les causes fœtales. On va commencer par les causes maternelles qui sont les plus fréquentes et représentées essentiellement par les hypertensions artérielles gravidiques.

Surtout dans notre contexte marocain. Puis on peut retrouver aussi comme causes maternelles le diabète quand il est déséquilibré, les néphropathies. Toutes les hépatopathies, en particulier les hépatopathies gravidiques, la cholestase gravidique, la stéatose hépatique aiguë gravidique qui peut être aussi bien très grave pour la maman ou pour le fœtus.

Et puis à chaque fois qu'il y a une cardiopathie, une bronchopathie chronique, déséquilibrée, les infections materno-fœtales, la syphilis, la rubeo, la toxoplasmose, le cytomégalovirus, le parvovirus. La mort fœtale interne peut survenir aussi suite à un traumatisme, en particulier un accident de la voie publique, une chute. Et puis toutes ces causes-là peuvent favoriser la survenue de la mort fœtale interne ou en particulier une anémie chronique, la dénutrition, le surmenage ou des conduites addictives, en particulier le tabac.

Les causes annexielles, on retrouve essentiellement l'hématome rétro-placentaire, tous les placentas prévia-hémorragiques. L'hémorragie du bénéficiaire, c'est un repas d'un vaisseau d'origine fœtale avec une hémorragie aiguë chez le fœtus. Toutes les insuffisances placentaires, surtout dans le cadre des hypertensions ou des maladies de système.

La sénescence placentaire lorsque la grossesse se prolonge. Toutes les ischémies, les infarctus placentaires, les tumeurs bénignes, la chorio-angiome en placentaire, toutes les chaînes vasculaires,

les anomalies du cordon circulaire serré, un nœud, une procédance du cordon, une aplasie, une artère ombilicale et puis la rupture prématurée des membranes. Les causes fœtales.

On retrouve les anomalies chromosomiques dans 5 à 10% des morts fœtales in utero. Essentiellement, les trisomies 21, 13 et 18. Bien évidemment, quand on a fait le prélèvement fœtal, il faut faire le cariotype.

Et normalement, ça doit déboucher sur un conseil génétique. Il faut un laboratoire de ces études génétiques spécialisées. On trouve aussi toutes les malformations fœtales dans les syndromes polymalformatifs.

Les infections chorio-amniotiques et fœtales ascendantes au transplacentaire, essentiellement liées au streptococque et à l'hystéreuse. Les maladies hémolithiques. Malheureusement, dans notre contexte marocain, l'incompatibilité fœtomaternelle dans le système rhésus reste élevée par l'absence de prévention.

La bête de thalassémie. Dans les grossesses multiples, on peut avoir une mort fœtale in utero suite à un syndrome transfigure-transfigure. Quand on a fait un bilan exhaustif, la cause reste idiopathique dans 30% des cas.

Concernant le diagnostic positif. Sur le plan clinique, les circonstances de découverte, c'est soit que cette mort fœtale in utero est redoutée. C'est-à-dire qu'on a des antécédents lors de la surveillance d'une grossesse à haut risque.

Par exemple, surveillance d'un retard de croissance, etc. Ou la mort fœtale in utero peut survenir d'une manière brutale, inattendue. Les signes d'appel.

Souvent, il y a une disparition de la perception du mouvement actif du fœtus. Apparition de la mort antélétuse. Et puis il y a l'examen physique.

La hauteur utérine est diminuée par rapport à la hauteur qui doit exister. Perception négative des BCF, des brûlures du cœur fœtal. Et si on fait un toucher vaginal, on va trouver un chevauchement des os du crâne et une crépitation osseuse.

Le diagnostic repose surtout sur les examens par clinique. La radiographie du contenu utérin est abandonnée. Elle n'a plus d'intérêt avec l'échographie actuellement.

L'échographie obstétrique réalisée va montrer l'absence d'activité cardiaque. Donc il faut bien visualiser l'air cardiaque. Et éventuellement céder par le Doppler en cas de difficulté.

Et bien évidemment, on n'aura pas de mouvement actif. On peut avoir un décollement cutané, un chevauchement des os du crâne, une image à double contour. Surtout quand la morphe fœtale mutéro est ancienne.

Sur le plan étiologique, il faut faire une enquête exhaustive à la recherche d'une étiologie. Bien évidemment, il faut commencer par l'interrogatoire pour préciser l'âge de la patiente, sa justice, sa parité. Ses conditions socio-économiques, son niveau d'instruction.

Rechercher s'il y a des conduites addictives, des antécédents médicaux. En particulier la recherche de pathologies vasculaires ou des maladies systémiques qui peuvent être une cause directe de cette morpho fœtale. Un examen général en précisant le poids, l'état négationnel de la patiente.

Il faut mesurer sa tension artérielle, faire une bandelette multiréactive et un examen somatique complet. Et demander un certain nombre de bilans, en particulier sur l'imagerie. En particulier l'échographie obstétrique.

Surtout il faut faire une échographie morphologique à la recherche d'un syndrome polymalformatif. Faire un Doppler utérin. Si le Doppler utérin est pathologique, est beaucoup plus orienté vers une origine maternelle, vasculaire.

Faire une radiographie du fœtus. Et puis sur le plan biologique, on doit demander un groupage résus, un hémogramme, une glycémie agent et une glycémie postplantiale. Et une protéinurie de 24 heures, l'urée, la créatine.

Un bilan hépatique, un bilan immunologique et éventuellement un bilan infectieux. Et puis si on est plus orienté vers une étiologie d'origine fœtale. Et en cas de récurrence de ces morts fœtales, on peut faire un caréotype fœtale, un caréotype de parent.

Et des fois, en cas d'anomalie génétique, on peut faire une étude moléculaire. Et dans des centres équipés, on doit faire de la fœtopathologie avec une étude anathémopathologique du fœtus et du placenta. Donc une fois le diagnostic échographique et fait de morts fœtales immunitaires, il faut voir le contexte clinique et échographique qui peuvent être évocateurs.

Soit dans le cadre d'un tableau vasculaire, une pathologie maternelle connue telle que le lupus, le syndrome des antiphospholipides. Ou une pathologie vasculo-placentaire type pré-eclampsie, elb-syndrome ou de la Shérpé. Là, il faut faire ce bilan, l'immigration ionogamme, la protéine, un bilan hépatique et un bilan de thrombophilie à distance.

Et puis des fois, on a une cause évidente, par exemple un diabète déséquilibré. Et puis si vous avez un saignement concomitant, il faut voir s'il y a une notion de traumatisme. Et des fois vous avez un contexte infectieux, par exemple une rupture primitivement ombrane, un choc septique suite à un chorio-amnionite, un tableau grippal, un hasard à l'échographie.

Donc là, il faut faire tous les prélèvements dans ce sens-là. Et puis en absence d'éléments d'orientation, donc il n'y a pas de contexte évocateur, il faut faire un bilan initial systématique. Donc une immigration TPTCK, un immunogramme, des hémocultures, un ECBU et puis toutes

les sérologies possibles.

Et on peut à ce moment-là retrouver des sérologies. Sinon, on peut aller jusqu'à l'examen phétopathologique avec éventuellement des analyses génétiques. Quelles sont maintenant les complications maternelles ? Donc la morphée thalimthéo expose à des complications parfois très graves chez la maman.

Ces complications sont de trois ordres. D'abord les complications infectieuses, surtout après rupture des membranes. Une infection amniotique ascendante.

On peut avoir des germes souvent multiples et avec un risque de choc toxique infectieux qui peut conduire au décès. Et puis vous avez les complications hémorragiques, souvent au cours de la période de la délivrance. Une CVD, un passage de thromboplastie.

Et puis c'est pourquoi il faut faire un bilan d'hémorragie systématique et répéter. Et puis il y a les complications psychologiques. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique de ces femmes-là qui sont en dépression ou en psychose pulvérale.

Et il faut respecter la période de dé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Une fois le diagnostic posé, on doit chercher rapidement s'il y a une cause évidente. Et si la mort fétale est récurrente, il faut pousser les investigations.

Et puis il faut avoir une conduite et évacuer l'utérus afin d'éviter les complications maternelles. Donc avant, on fait ce qu'on appelle l'expectative. En attendant que la patiente rentre au travail et l'expulsion peut survenir de manière spontanée.

Mais avec cette attitude-là, il y a des risques infectieux et hémorragiques très importants. C'est pourquoi on préfère une extraction rapide. Soit par déclenchement du travail, par le cytotocine, les prostaglandins ou la méfibrestone.

L'extraction chirurgicale, parfois on fait une césarienne, parfois vaginale ou par voie haute. C'est surtout quand il y a des urgences vitales. Par exemple, un hématome rétroplacentaire qui peut se compliquer, s'aggraver rapidement.

Une prééclampsie ou quand il y a une complication, une autre méthode d'évacuation, parfois vaginale. Il ne faut pas oublier la prévention de l'hémorragie, de la diluvance parce que c'est très très fréquent dans ce contexte-là. Et surtout quand il y a des anomalies de moustache.

N'oubliez pas de faire une prévention de l'aluminization si la patiente est résiste moins. Et il ne faut pas en plus oublier d'inhiber, d'éviter de monter les thèses. Donc, soit on fait l'aluminization dans un contexte d'urgence maternelle et on déclenche immédiatement.

Soit il n'y a pas de contexte d'urgence. Là, on demande le bilan des moustaches, c'est normal. On peut déclencher soit par la myfiprestone ou les analogues de prostaglandine.

Et exceptionnellement, on fait une césarienne d'indication obstétrique par exemple quand il y a un placenta préviens. Alors la prévention, on peut parler de la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire repose sur l'amélioration de la condition féminine, sur une politique, une vraie politique nationale de périnatalogie.

Une information et sensibilisation à grande échelle, aussi bien la population que les médecins. Une surveillance prénatale adaptée à chaque cas et puis il faut faire une prise en charge correcte des grossesses à haut risque. Et puis, vous avez la prévention secondaire qui repose en fonction de l'enquête étiologique.

Par exemple, s'il y a une cause identifiée, ça doit déboucher sur un conseil génétique si la cause est chromosomique ou génétique. Sur l'aspirine, en cas de contexte évocateur de maladies de système, des fois dans les maladies de système on peut donner des corticoïdes. En cas de thrombophilie, on peut prescrire l'héparinothérapie et puis sur un traitement d'une pathologie générale.

Et si la cause n'est pas retrouvée, il faut faire un plan de surveillance des grossesses à haut risque avec une extraction à maturité fœtale. Donc là, cette diapositive résume la prise en charge de la grossesse suivante, c'est pour éviter les récurrences. Et en conclusion, la mortalité périnatale demeure un problème de santé publique au Maroc.

Le diagnostic échographique est aisé, l'évacuation doit être rapide afin d'éviter les complications maternelles qui peuvent être très graves. L'enquête étiologique, surtout pour les morts fœtales, est à répétition. L'intérêt d'une surveillance périnatale correcte.

Et puis, il faut qu'il y ait la responsabilité de tous les intervenants, aussi bien politiques que civils et médicaux, pour diminuer le taux de mortalité périnatale dans notre contexte marocain. Je vous remercie.